

TEMA 3.37 • OBSTETRICIA

RCIU — Momentos y Vía de Interrupción

PERFIL EUNACOM 1.03.37
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

RCIU — Momentos y Vía de Interrupción

Tabla de Interrupción según Tipo

TABLA 3.37.1: TIPO VS HALLAZGO DOPPLER			
TIPO	HALLAZGO DOPPLER	INTERRUPCIÓN	VÍA
PEG	Normal	38–40 semanas	Vaginal
RCIU tipo 1	IP umbilical > p95 o < p3 con Doppler umbilical normal	37 semanas	Vaginal
RCIU tipo 2	Flujo ausente en diástole	33–34 semanas + corticoides	Cesárea
RCIU tipo 3	Flujo reverso en diástole	30–32 semanas + corticoides	Cesárea
RCIU tipo 4	Ducto venoso reverso	26 semanas (viabilidad)	Cesárea
Sufrimiento fetal agudo	Perfil biofísico ominoso	Inmediato	Cesárea urgente

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Desde que se confirma **RCIU tipo 1**, se interrumpe al llegar a las 37 semanas — aunque esté estable y todo parezca bien. No hay razón para esperar más.

Perfil Biofísico Ominoso = Interrupción Inmediata

TABLA 3.37.2: PUNTAJE PBF VS LA (LÍQUIDO AMNIÓTICO)		
PUNTAJE PBF	LA (LÍQUIDO AMNIÓTICO)	INTERPRETACIÓN
≤ 4/10	Cualquiera	Ominoso → interrumpir
6/10	0/2 (alterado)	Ominoso → interrumpir
6/10	2/2 (normal)	No ominoso → observar
≥ 8/10	Cualquiera	Tranquilizador

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **líquido amniótico** es el parámetro más importante del perfil biofísico. Un puntaje de 6/10 con LA normal → observar. Con LA = 0 → ominoso → interrumpir de inmediato.

Regla General

- **PEG y RCIU tipo 1:** vía vaginal (Doppler umbilical sin alteración del flujo)
- **RCIU tipos 2, 3, 4:** cesárea (feto hipóxico → no soportar trabajo de parto)
- Todos los RCIU que se interrumpen antes de 34 sem → **corticoides antenatales**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a RCIU — Momentos y Vía de Interrupción: Perfil biofísico ominoso | Inmediato | Cesárea urgente | ::tip Desde que se co... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para RCIU — Momentos y Vía de Interrupción. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tabla de Interrupción según Tipo
- Perfil Biofísico Ominoso = Interrupción Inmediata
- Regla General
- | Normal | 38–40 semanas | Vaginal | |
- | IP umbilical > p95 o < p3 con Doppler umbilical normal |
- | Flujo ausente en diástole |
- | Flujo reverso en diástole |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RCIU — MOMENTOS Y VÍA DE INTERRUPCIÓN)

PREGUNTA 1

En relación a RCIU — Momentos y Vía de Interrupción: Perfil biofísico ominoso | Inmediato | Cesárea urgente | ::tip Desde que se co... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de RCIU — Momentos y Vía de Interrupción se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de RCIU — Momentos y Vía de Interrupción debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con RCIU — Momentos y Vía de Interrupción requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de RCIU — Momentos y Vía de Interrupción es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de RCIU — Momentos y Vía de Interrupción no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en RCIU — Momentos y Vía de Interrupción?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con RCIU — Momentos y Vía de Interrupción. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: RCIU — MOMENTOS Y VÍA DE INTERRUPCIÓN

:::tip Desde que se confirma RCIU tipo 1, se interrumpe al llegar a las 37 semanas — aunque esté estable y todo parezca bien. No hay razón para esperar más. ::::warning El líquido amniótico es el parámetro más importante del perfil biofísico. Un puntaje de 6/10 con LA normal → observar. Con LA = 0 → ominoso → interrumpir de inmediato. :::